Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Matías Alejandro Ruiz Mora			Sexo	F		M X
Fecha Nacimiento	15-07-2013	Edad actual	años	meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Glaciar Juncal 82 V. Cordillera III			Teléfono	993939421		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Escolaridad actual:	5to	Establecimiento	Liceo Mixto Básica Nº2				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista:	28/03/2025	2. Fecha de la entrevista:	
Nombre: Viviana Ruiz Mora		Nombre:	
Relación con el/la estudiante: Madre		Relación con el/la estudiante:	
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	
3. Fecha de la entrevista:		4. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Relación con el/la estudiante:		Relación con el/la estudiante:	
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)		En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):	

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	28/03/2025	2. Fecha de la entrevista:	
Nombre: Erika Olguín Briceño		Nombre:	
Rol/cargo: Ed. Diferencial		Rol/cargo:	
3. Fecha de la entrevista:		3. Fecha de la entrevista:	
Nombre:		Nombre:	
Rol/cargo:		Rol/cargo:	

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

- Solicitar autorización para realizar evaluaciones para confirmar y/o descartar diagnóstico.
- Realizar entrevista anamnesis

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí **(especificar)**

Pediatría:		Psicología:	✓
Kinesiología:		Psiquiatría:	
Genético:		Psicopedagogía:	✓
Fonoaudiología:	✓	Terapia Ocupacional:	✓
Neurología:	✓	Otro:	

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo): Urgencia, bajó latidos del corazón

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO	Peso: 2kg 800gr	Talla: 47 cm

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

- nació con una laringomalacia.
- Sin dificultades en el embarazo.
- nació de 8 meses.
- madre rompió fuente espontáneamente

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	~~Sí~~	No	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	~~Sí~~	No	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración: 1 día al año de vida para bajar fiebre.					
Se realizaron controles periódicos de salud		Sí	No		Vacunas		Si	No

Observaciones:

Convulsiones por fiebre alta, no recurrente; fue hospitalizado por 24 horas.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 8m	Se sienta sólo/a: no recuerda	Camina sin apoyo: 1a 6m
Primeras palabras: 1a6m	Primeras frases: 2a	Se viste solo/a: 3a6m.
Controla esfínter vesical Diurno: 4a Nocturno: 4a		Controla esfínter anal Diurno: 3a6m Nocturno: 3a6m

Observaciones:

- Usó chupete hasta los 7a, igualmente mamadera.

En su actividad motora general se aprecia:

☐ normal ☐ activo ☑ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:

☐ normal ☑ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	~~Sí~~	~~No~~

Observaciones:

Sin observaciones.

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	~~Sí~~	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones: miopía y astigmatismo; controlado

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma ☑ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	~~Sí~~	No	Emite/produce frases	~~Sí~~	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	~~Sí~~	No	Relata experiencias	~~Sí~~	No
Emite palabras/produce señas	~~Sí~~	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	~~Sí~~	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones simples	~~Sí~~	No
Identifica personas	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones complejas	~~Sí~~	No
Comprende conceptos abstractos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	~~No~~
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): atraso en aprox. 6 meses.					
Observaciones: El sentimiento que más comunica es la rabia, frustración, el miedo					

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	~~No~~	Se relaciona en forma colaborativa	~~Sí~~	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	~~Sí~~	No	Respeta normas sociales	~~Sí~~	No
Participa en actividades grupales	Sí	~~No~~	Respeta normas escolares	~~Sí~~	No
Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados	~~Sí~~	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	~~Sí~~	No	Pataletas frecuentes	Sí	No ?
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☑ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☑ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada		
Observaciones: Hay pataletas de descompensación.					

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante					
Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	~~Sí~~	~~No~~
Pérdida auditiva	Si	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	~~Sí~~	No	Otro (especifique):		
El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Sin observaciones.					
Alimentación: ☐ normal ☑ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)					
Peso (apreciación del informante): ☐ normal ☐ bajo peso ☑ obesidad					
Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☑ inquieto Horas que duerme: 6 a 5 horas.					
☑ insomnio ☑ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor			Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):		
Humor/comportamiento ***(señale el comportamiento habitual)***					
☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☑ apático ☐ violento(a) Otro:					
Observaciones: Selectivo para comer.					

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Viviana Mora M.	Madre	41	4°E-M.	Dueña de casa
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Primo por parte de padre autismo severo al igual que el padre de este.
Abuelo paterno autismo paterno.

Observaciones:

Sin observaciones.

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4a	Asistió a jardín infantil	Sí / No
N° de colegios en que ha estudiado	03	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:	

Motivo de los cambios:

Aprendizaje desconforme con educación; episodios de bullying.

Ha repetido curso/s	Sí	No	Curso(s) 1°	Motivo:	no adquirió la lectura.						

Situación actual

Nivel/curso actual	5°		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No	**Dificultad para participar**	Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí	No
Asiste regularmente	Sí	No	Asiste con agrado	Sí	No	Apoyo familiar en tareas	Sí	No	Amigos (as)	Sí	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☑ insatisfactorio (motivos) ..tiene capacidades.....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☑ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☑ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☑ madre ☐ padre ☐ hermanos/as ☑ Otros familiares ☐ Otros profesionales ..padrastro / neurólogo / T.O.....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- 2o T.O. solicita evaluación de neurólogo infantil por posible medicación.
- Prematuro: hospitalizado 1 semana con la madre, luego 3 semanas solo, por esta razón no tomó leche materno.
- operado; fimosis a los 10 años.
- Testículo no ha bajado aunque fue operado.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY